

La comunidad como espacio terapéutico: por qué la RBC puede mejorar la atención de la comunicación en el Perú

En el mundo, más de mil millones de personas, cerca del 15 % de la población, viven con alguna discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011), pero las personas con trastornos de la comunicación pueden no estar representadas con exactitud en esas estimaciones, lo que resta atención a su rehabilitación y a su apoyo en la comunidad (Wylie et al., 2013). En el Perú, la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) registró que el 5.2 % de la población tiene algún tipo de discapacidad (Torres Arias y Villalonga Aragón, 2020), y la Ley N.º 29973 (2012) reconoce el derecho de estas personas a recibir atención de salud y rehabilitación dentro de su comunidad. Frente a ello, cabe preguntarse si la consulta individual basta para garantizar ese derecho. En este ensayo sostengo que la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) puede mejorar la atención de las personas con trastornos de la comunicación en el Perú, porque amplía el alcance de los servicios especializados mediante la capacitación de familias y agentes comunitarios, y porque cuenta con un marco normativo e institucional local que ya la contempla.

En primer lugar, la RBC permite llegar a quienes la atención clínica individual no alcanza. El Informe mundial sobre la discapacidad señala que los servicios de logopedia son prácticamente inexistentes en muchos países y recomienda que, donde los recursos y la capacidad son escasos, se acelere la prestación de servicios en las comunidades mediante la RBC, complementada con la derivación a servicios secundarios (OMS y Banco Mundial, 2011, pp. 122, 130). Wylie et al. (2013) explican que las terapias directas, institucionales y de nivel terciario consumen más recursos del terapeuta por persona atendida y limitan su alcance, mientras que los servicios comunitarios, primarios e indirectos pueden llegar a más personas; entre los agentes posibles mencionan a familiares, docentes y enfermeras guiados por el terapeuta (pp. 7-8). A ello se suma que, en dos estudios poblacionales, solo un tercio de los niños identificados con dificultades había buscado ayuda o había sido derivado a un terapeuta (Law et al., 2013). Estos datos muestran que esperar a que la persona llegue al consultorio deja sin atención a

muchos; capacitar a quienes conviven con ella lleva la terapia a la vida diaria y, así, vincula la RBC con un mayor acceso.

En segundo lugar, el Perú dispone de un marco legal que ya exige y habilita este modelo. La Ley N.º 29973 (2012) establece que la persona con discapacidad tiene derecho a recibir su atención de salud y rehabilitación dentro de la comunidad en que vive, con enfoque intercultural (art. 29), y dispone que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales formulen y ejecuten estrategias de RBC con la participación de la persona, su familia y su comunidad (art. 31.1). Asimismo, el Estado debe orientar y capacitar a las familias (art. 5), y cada municipalidad debe contar con una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) que coordine y supervise los programas locales (art. 70). La RBC, entendida como una estrategia de desarrollo inclusivo basado en la comunidad y en los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (OMS et al., 2012, p. 1), ofrece el camino para cumplir ese mandato. Además, hay evidencia de su viabilidad con pocos recursos. En una zona rural de la India, personas de la comunidad capacitadas como trabajadores de RBC identificaron a pacientes con esquizofrenia crónica y aseguraron su atención clínica, y los resultados fueron mejores que con la atención ambulatoria sola (OMS et al., 2012, p. 6).

Podría objetarse que la RBC es difícil de sostener en el Perú, pues su aplicación local ha mostrado debilidades. En efecto, la que sus autoras describen como la primera investigación nacional sobre la aplicación de la RBC, realizada en el servicio de atención a personas con discapacidad de Puente Piedra, encontró fallas en la articulación, la participación, el fortalecimiento de capacidades y la experiencia del equipo ejecutor, que no garantizaban la sostenibilidad del servicio (Torres Arias y Villalonga Aragón, 2020). Sin embargo, estas fallas señalan cómo mejorar la implementación, no que el modelo sea inadecuado. Wylie et al. (2013) subrayan que los terapeutas necesitan formación para educar a familias, cuidadores y docentes (p. 10) y advierten contra importar modelos sin adaptarlos a cada contexto (p. 9). Es decir, la respuesta a las debilidades es más capacitación, supervisión y adaptación local, no el abandono de la RBC.

En conclusión, la RBC puede mejorar la atención de las personas con trastornos de la comunicación en el Perú, porque multiplica el alcance de los servicios especializados y se apoya en un marco legal e institucional que la respalda. Como propuesta, cada municipalidad distrital podría coordinar, desde su OMAPED y junto con el establecimiento de salud de su zona, un programa en el que un terapeuta de lenguaje capacite y supervise a familias y agentes comunitarios, y derive a servicios especializados los casos que lo requieran. Así, se concretaría en el ámbito local el derecho a recibir rehabilitación dentro de la comunidad que reconoce la Ley N.º 29973.

Referencias

1. Law, J., Reilly, S. y Snow, P. C. (2013). Child speech, language and communication need re-examined in a public health context: A new direction for the speech and language therapy profession. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 48(5), 486–496. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12027>
2. Ley N.º 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad. (2012). Diario Oficial El Peruano.
3. Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. (2011). *Informe mundial sobre la discapacidad*. OMS.
4. Organización Mundial de la Salud, UNESCO, Organización Internacional del Trabajo y Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo. (2012). *Guías para la RBC: Folleto complementario*. OMS.
5. Torres Arias, K. L. y Villalonga Aragón, L. (2020). *Análisis de los factores que limitan y/o contribuyen en la implementación del Servicio de Atención Integral de Personas con Discapacidad (SAIPD) en el distrito de Puente Piedra, 2017* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio de Tesis PUCP. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/15692>
6. Wylie, K., McAllister, L., Davidson, B. y Marshall, J. (2013). Changing practice: Implications of the World Report on Disability for responding to communication disability in under-served populations. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.3109/17549507.2012.745164>